

Fecha Última Actualización: 11-02-2023 17:45:10

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Ricardo Lepin Colihuinca
Edad : 42a 3m 26d
Dirección : Dg. Sta. Cruz 0936

Rut : 14.182.542-9
Fecha Nacto: 16/10/1980
Comuna : La Pintana

N° Archivo : 0409419
Sexo : Masculino
Teléfono : 123456789

N° Epicrisis
338469

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Ingreso : 20/12/2022 03:43

Días Estadía: 53

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4to Piso)

Fecha Egreso : 11/02/2023 17:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Anamnesis remota:

- Antecedentes mórbidos: DHC Child A (sin estudio), TUS PBC/OH/tabaco, epilepsia, hematoma subdural agudo (julio 2021, con HSA, Fx peñasco y esfenoides, contusiones frontales).
- Antecedentes quirúrgicos: Craniectomía descompresiva 20/12/22 + captos PIC y PtO2
- Medicamentos: Levetiracetam (mala adherencia al tratamiento)
- Alergias: No descritas
- Hábitos: TBQ (+), OH (+), otras drogas (+) PBC

Historia actual:

Paciente con antecedentes descritos es derivado al servicio de urgencias desde HPH por TEC con imagen compatible con hematoma frontotemporal derecho, HSA, hematoma subdural parasagital derecho y hematoma epidural.

A su ingreso se describe en regulares condiciones generales, con otorraquia al examen físico, pupilas isocóricas, normorreactivas, GSC 14/15 y hemiparesia braquiocrural izquierda. Recibe levetiracetam en dosis de carga, se realiza angioTC de cerebro que evidencia contusión temporal derecha grande, contusión parietal derecha, pequeño hematoma subdural interhemisférico frontal.

Indicación quirúrgica urgente, según consta en protocolo operatorio se realizó:

- Aseo quirúrgico
- Incisión tipo trauma frontotemporoparietal ftp derecho
- Craneotomía amplia frontotemporoparietal derecha
- Craniectomía descompresiva. Dura a tensión sin evidencia de pulsaciones.
- Durotomía en forma estrellada, identificándose colección subdural aguda que se evacua.
- Tejido encefálico muy contundido a nivel fronto temporal derecho
- Cierre del abordaje craneano por planos
- Placa ósea se conserva a nivel de cuadrante subcutáneo superior derecho abdominal.
- Se instala en forma clásica sensor de PIC raumedic pre coronal izquierdo.

En ese contexto ingresa a UCI conectado a VMI protectora, sedado, RASS -5, pupila izquierda miótica, derecha no evaluable por edema palpebral, hiporreactivas, craniectomía derecha.

EVOLUCIÓN EN UCI (20/12/22 - 12/01/23)

HDN: A su ingreso con req de NAD hasta 0.35 ug/kg/min. Post 1° operatorio con altos requerimientos de DVA. Evolucionando con

Fecha Epicrisis : 11/02/2023 17:45

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 11-02-2023 17:45:10

Página 2 de 4

destete progresivo, sin DVA desde 25/12.

Respiratorio: Sin posibilidad de weaning por mala evolución neurológica. Se efectúa TQT percutánea el 27/12, con buena tolerancia a filtro desde 28/12. Impresiona sin potencial de rehabilitación para decanulación.

Evoluciona con bajos requerimientos de O2 en contexto de traqueobronquitis vs neumonía, destetado el 10.01.

Infeccioso Inicialmente AMS como profilaxis mientras mantuvo invasivos neurológicos. Cursando infección de foco respiratorio por PSAE, en tratamiento con ceftazidima. En día 7 de ceftazidima (06.01), nuevamente febril.

Con microbiología aislada previa CAET (+) PSAE resistente a carbapenémicos, por lo que se mantiene Ceftazidima (a completar 10 - 14 días), y se agrega Meropenem + Vancomicina.

Se pancultiva, obteniéndose una OC levemente inflamatorio (5-10 GB) y se solicita TAC TAP con contraste.

Por quiebre de stock de meropenem y estable clínicamente, se reemplazará de momento por tazonam en dosis antipseudomonica (FI 07.01).

Se realiza TAC TAP donde destaca signos de traqueitis y colección de sitio quirúrgico abdominal bajo calota (impresiona en aumento respecto a TAC previo, resto pendiente. Sin posibilidad de realizar PL dado alto riesgo de herniación (según evaluado por neurología). Se ajusta antibioticoterapia a Imipenem + Ceftazidima, se suspende vancomicina(09.01)

Evaluado por neurocirugía para manejo de colección peri calota quienes refieren que no requiere manejo dirigido.

Neuro/Neuroqx: Paciente con TEC grave y HSD agudo que requirió hemicraniectomía descompresiva derecha (en total 2 intervenciones, 20 y 22/12 drenaje de hematoma por efecto de masa) y captor de PICC (retirado 28/12). EE 29/12 sin informe en sistema. Sin episodios convulsivos. Se mantiene con fenitoina + levetiracetam como terapia anticonvulsiva. Se mantuvo en seguimiento por neurocirugía en UCI, determinando muy mal pronóstico.

Evaluado por neurología de turno el 07.01 por persistencia de compromiso de conciencia asociado a nistagmus, impresiona sin sospecha de status epileptico, explicable por lesión conocida, sugiere mantener FAE y evaluación por neurología con nueva imagen para determinar si mantener FAE y pronóstico neurológico, obs lesión de troncoencefalo secundaria a herniación.

Se solicita control de TAC de cerebro que evidencia Colección hidroaérea asociada material protésico de tejido celular subcutáneo de la pared abdominal en flanco derecho, de 11,2 x 1,9 cm, su pared poco definida. Se evalúa caso con neurología y neurocirugía. Actualmente sin requerimiento de nuevos procedimientos quirúrgicos, con evolución imagenológica favorable, colección peri calota esperable e impresiona de origen no infeccioso. En el contexto de trauma, pronóstico de difícil determinación antes de 6 - 8 meses, sin embargo, se espera que en caso de recuperación, ocurra con hemiplejía izquierda y dependencia severa. Sugieren realizar craneoplastia a lo menos 6 meses post descompresiva.

En cuanto a epilepsia, se ajustó esquema a fenitoina y levetiracetam, con dosis ajustadas por neurología. Destaca al EEG 10/01 con AE intermitente, reevaluado hoy con neurología, se decidió agregar diazepam PM.

Evaluado por neurología, sugieren Iniciar Diazepam 5 mg noche mientras esté con carbapenemicos

Gastrointestinal: En laboratorio 08.0 destaca elevación significativa de GGT y FA, bilirrubina y transaminasas normales. Se realiza TAC con contraste sin alteraciones en vía biliar/hígado.

Rehabilitación: rehabilitación multimodal con KTM, KTR y FNA, aportes nutricionales por SNG.

EVOLUCIÓN EN SALA BÁSICA (12/01/22 - 10/02/23):

Hemodinamia: estable, no es conflicto.

Neurología/Neuro Cx: Evoluciona estacionario, en última evaluación por especialidad les impresiona pronóstico probable mRS4 (Discapacidad moderadamente grave) y demencia post TEC/post-infarto. Bajo potencial rehabilitable dada gravedad de lesiones y nula cooperación de paciente en lo motor.

Infeccioso: Completa tratamiento para traqueobronquitis por PSAE que se maneja con ceftazidima (14/14), por persistir febril se asoció imipenem (7/7). TC TAP colección alrededor de calota que evaluado por neuro Cx es esperable, sin indicación qx. Dado ominoso pronóstico neurológico se decide AET sin ATB y cultivos.

Rehabilitación: No decanulable, se realiza manejo sintomático con anticolinérgicos e ipratropio para secreciones. Pendiente realización de gastrostomía.

Fecha Epicrisis : 11/02/2023 17:45

Página 2 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:31

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 11-02-2023 17:45:10

Página 3 de 4

Social: Se conversa con hermano Carlos. Refiere no tener medios para cuidar a su hermano y que ya está cuidado a otro familiar postrado (su padre), vive también con su madre, de tercera edad con comorbilidades. Se explica pronóstico y se decide en conjunto realizar AET. Firma documento de adecuación del esfuerzo terapéutico. Se solicita traslado a HSJM para manejo paliativo.

Pendiente gastrostomía

Diagnósticos de egreso:

TEC grave complicado

- Hematoma frontotemporal D°, HSA, Hematoma subdural parasagital D°, Hematoma epidural.

- HTIC severa

- Herniación transcraniectomía.

- Herniación transtentorial, herniación uncal y subfalcina

- Infartos de ACA y ACP derechas 2° a herniación transtentorial

- Restricción de difusión en ganglios basales bilateral + pontino - ¿mielinolisis vs infarto

Pronóstico neurológico reservado por extenso daño encefálico y de tronco

- Mejor Rankin esperado mRS 4 y demencia post-TEC

- Compromiso cuantitativo de conciencia - GCS3 sostenido

- Usuario de TQT y en plan de GTT

Antecedentes: DHC Child A (sin estudio), TUS PBC/OH/tabaco, epilepsia 2°, hematoma subdural agudo (julio 2021, con HSA, Fx peñasco y esfenoides, contusiones frontales).

Diagnóstico de Egreso

Tec Grave -

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J:NO

Hemodinámicamente estable, afebril, sin requerimientos de O2. No conecta con examinador, GCS 3.

Plan Post Alta

Indicaciones

Reposo en cama. Movilizar por kine.

Régimen cero por boca, SNG:

- Fresubin a 60 ml/h + agua libre 50 ml/h SNG

- Interrumpir NE 1 hora pre y post administración de fenitoína

O2 para sat 92%

KTM, KTR, FNA

Mantener TQT, SNG, CUP

Fenitoína 100 - 200 mg SNG

Levetiracetam 1 g cada 12 h SNG

Diazepam 5 mg/noche SNG

Paracetamol 1 g cada 8 h SNG

Atropina 1 ampolla + SS 0,9% 10cc: aplicar 1cc SL c/ 6 hrs

Bromuro de Ipratropio 2 puff c/ 4 hrs en cavidad bucal

Clotrimazol 1 aplicación en zonas afectadas, cada 12 horas, por 14 días (8/14)

Metamizol 1 g EV SOS fiebre

No RCP, NO DVA, NO cultivar, NO ATB, NO exámenes

En caso de hemorragia o clínica catastrófica iniciar sedación paliativa.

Proporcionar cuidados básicos.

Adecuación del esfuerzo terapéutico.

información sobre condición clínica a Hermana +569 65 29 99 42

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 11/02/2023 17:45

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:31

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 11-02-2023 17:45:10

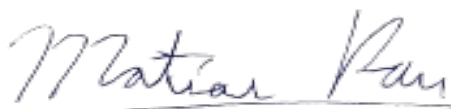
Tipo de Reposo : Absoluto

Régimen Alimentario : Sng + Fresubin A 40 Cc/H + Agua A 40 Cc/H

Medicamentos : Levetiracetam 1 Gr C/12 Hrs Vo
Fenitoina 100-200 Mg Vo
Diazepam 5 Mg Noche Vo
B. Ipratropio 2 Puff C/6 Hrs Directo En La Boca.

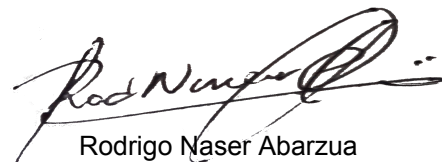
Controles

INTERNO



Matias Bec Rau Moreno

Becado/Residente



Rodrigo Naser Abarzua

Médico Tratante (Staff)